

ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะแห่งตนสำหรับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงในชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์
The effectiveness of the self - efficacy enhancement program
for village health volunteers in caring for patients with Diabetes Mellitus
and Hypertension in community in Buriram Province

กิตติพงษ์ เรือนเพชร* และวาสุกรี สายเพชร**

Kitipong Ruanphet,* and Wasugree Saipech**

*คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

**โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาท

*Faculty of Nursing Buriram, Western University

** Prasat Health Promoting Hospital

บทคัดย่อ

การวิจัยแบบกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะแห่งตนสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่าง เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 66 คน เลือกรูปแบบเจาะจง แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 33 คน เครื่องมือวิจัย เป็นโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะแห่งตน แบบทดสอบความรู้แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะแห่งตน และแบบประเมินทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย และการทดสอบที ผลการศึกษาพบว่า หลังการทดลอง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยความรู้ การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง สูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

คำสำคัญ: โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะแห่งตน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, โรคเบาหวาน,
โรคความดันโลหิตสูง

ได้รับทุนสนับสนุนเผยแพร่ผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Corresponding author E-mail: kitipong.ru@western.ac.th

วันที่รับบทความ: 31 ธันวาคม 2566 วันที่แก้ไขบทความ: 2 มิถุนายน 2567; วันที่ตอบรับบทความ: 16 มิถุนายน 2567

หรือบทบาท 6 ประการของ อสม. คือ แก่ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้นำบริการ ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ประชาชน ดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดี

ในเขตสุขภาพที่ 9 ความชุกของโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานพบว่ามีผู้ป่วยโรคเบาหวาน จำนวน 343,225 คน โรคความดันโลหิตสูง จำนวน 665,337 คน และจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ป่วยโรคเบาหวาน จำนวน 72,322 คน โรคความดันโลหิตสูง จำนวน 141,139 คน (สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9, 2565) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ใน พ.ศ. 2564 - 2566 มีอัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นทุกปี จากร้อยละ 12.97, 14.81, และ 15.25 ตามลำดับ และอัตราป่วยด้วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นทุกปี จากร้อยละ 5.42, 6.14, และ 6.88 ตามลำดับ (กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มรายงานมาตรฐาน, 2566)

การศึกษาการมีส่วนร่วมของ อสม. ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานพบว่าปัญหาการทำงานในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานคือ ความรู้ในการดูแลผู้ป่วย (วรางคนา บุตรศรี และอภิรดี เจริญบุญกุล, 2560) อสม. ร้อยละ 66.5 ปฏิบัติงานอยู่เพียงในระดับปานกลาง (ภูติหิ เตชาติวัฒน์ และ นิทรา กิจธีระวุฒิจวงษ์, 2557) ซึ่งอาจจะทำให้การดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนไม่เต็มที่ การฝึกอบรมของอาสาสมัครสาธารณสุขพบว่าช่วยเพิ่มความสามารถในการดูแลผู้ป่วย และลดภาระที่เกิดจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในระดับชุมชนได้ (Pitchalard et al., 2022) ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องนี้เพื่อช่วยส่งเสริมและเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของ อสม. ให้มีความรู้ มีความมั่นใจและมีทักษะในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้อย่างถูกต้องตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะแห่งตนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ในชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้

1. เปรียบเทียบความรู้ การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนและหลังการทดลอง
2. เปรียบเทียบความรู้ การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ระหว่างก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม

สมมติฐานการวิจัย

โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะแห่งตนมีประสิทธิผล โดยทำให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีความรู้ การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น

1. หลังการทดลอง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในกลุ่มทดลอง มีความรู้ การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง สูงกว่าก่อนการทดลอง
2. หลังการทดลอง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในกลุ่มทดลอง มีความรู้ การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง สูงกว่ากลุ่มควบคุม

กรอบแนวคิดของการวิจัย ผู้วิจัยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะแห่งตน (self-efficacy theory) ของ Bandura (1997) ที่อธิบายว่าบุคคล จะตัดสินใจกระทำพฤติกรรมหรือไม่นั้น ส่วนหนึ่งมาจากการรับรู้สมรรถนะแห่งตนว่าจะกระทำพฤติกรรมนั้น ๆ ได้สำเร็จตามจุด

เครียด และการรับประทานยา การตอบเป็นแบบถูกและผิด กำหนดคะแนน 1 และ 0 ตามลำดับ

4. แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 20 ข้อ เนื้อหาครอบคลุมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการส่งเสริมสุขภาพโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ได้แก่ การควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย การผ่อนคลายความเครียด การรับประทานยา และมาตรวจตามนัด การตอบใช้มาตราประมาณค่า 4 ระดับ ได้แก่ มั่นใจมาก มั่นใจ ไม่ค่อยมั่นใจ และไม่มั่นใจเลย กำหนดคะแนน 4 ถึง 1 ตามลำดับ

5. แบบประเมินทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 10 ข้อ เนื้อหาครอบคลุม การควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย การผ่อนคลายความเครียด การรับประทานยา และการมาตรวจตามนัด การตอบใช้มาตราประมาณค่า 3 ระดับ ได้แก่ ทำได้ถูกต้อง ทำได้ถูกต้องบางส่วน และทำไม่ได้ กำหนดคะแนน 3 ถึง 1 ตามลำดับ

คุณภาพของเครื่องมือวิจัย ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบความรู้ แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะแห่งตน และแบบประเมินทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ประกอบด้วยอาจารย์พยาบาล 3 ท่าน พยาบาลวิชาชีพที่มีความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน 2 ท่าน หาค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (content validity index [CVI]) ได้ เท่ากับ 0.90, 0.95 และ 0.90 ตามลำดับ และหาความเที่ยงโดยนำไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจำนวน 30 คน หาค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของแบบทดสอบความรู้ ด้วย KR 20 และครอนบาคแอลฟา (Cronbach's alpha coefficient) ได้ค่าเท่ากับ 0.90, 0.87 และ 0.91 ตามลำดับ

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง โครงการวิจัยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลข BRO2023-079 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีดำเนินการวิจัย และการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล แก่กลุ่มตัวอย่าง และให้ลงนามยินยอมก่อนเข้าร่วมการวิจัย

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการช่วงเดือนกันยายน ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2566

กลุ่มทดลอง เข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะแห่งตนสำหรับ อสม. ในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน จัดโดยผู้วิจัยและคณะ หอประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาท ในระยะเวลา 5 สัปดาห์ ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง 30 นาที ดังนี้

สัปดาห์ที่ 1 ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบทดสอบความรู้ แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะแห่งตน และแบบประเมินทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ให้ อสม. ตอบใช้เวลา 15 - 30 นาที จากนั้นผู้วิจัยให้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ประกอบด้วย เนื้อหา การควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย การผ่อนคลายความเครียด การรับประทานยา และการมาตรวจตามแพทย์นัด และแบ่งกลุ่มสะท้อนความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สัปดาห์ที่ 2 เป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ตัวแบบอาสาสมัครสาธารณสุขที่เป็นโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลและความดันได้ดี มาเล่าประสบการณ์ให้ฟัง และฝึกทักษะการจัดอาหารที่เหมาะสมกับโรคในวัน อาหารทดแทน วิธีเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูป และอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง แบ่งกลุ่มสะท้อนความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สัปดาห์ที่ 3 แบ่งกลุ่มทดลองปฏิบัติจริงด้วยการฝึกทักษะการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ในเรื่อง การควบคุมอาหาร การออก

กำลังกาย การผ่อนคลายความเครียด การรับประทานยา และการมาตรวจตามแพทย์นัด โดยการจำลองสถานการณ์จริง

สัปดาห์ที่ 4 ผู้วิจัยให้ความรู้ในการวัดสัญญาณชีพ และการเจาะระดับน้ำตาลในเลือด (ปลายนิ้ว) และฝึกทักษะเบื้องต้นในการสาธิต และทดลองปฏิบัติจริงในการวัดสัญญาณชีพ การเจาะระดับน้ำตาลในเลือด (ปลายนิ้ว) พร้อมให้คำแนะนำเมื่อมีภาวะผิดปกติเพื่อพัฒนาศักยภาพ และสร้างความมั่นใจให้แก่ อสม. ในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

สัปดาห์ที่ 5 ผู้วิจัยทบทวนความรู้ ทักษะที่ได้เรียนรู้มาตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทำงาน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมีส่วนร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และวัดหลังการทดลองโดยให้ทำแบบทดสอบความรู้ แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะแห่งตน และแบบประเมินทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง

กลุ่มควบคุม

สัปดาห์ที่ 1 และ สัปดาห์ที่ 5 ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบทดสอบความรู้ แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะแห่งตน และแบบประเมินทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ให้กลุ่มตัวอย่างตอบ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาต ใช้เวลา 15 - 30 นาที ส่วนสัปดาห์ที่ 2-4 ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงจากบุคคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาตตามปกติ

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป คำนวณค่าของสถิติเชิงบรรยายโดยการแจกแจงความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ซึ่งข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

ผลการวิจัย

1. **ข้อมูลส่วนบุคคล** อสม. ในกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม เป็นเพศหญิง ร้อยละ 90.9 และร้อยละ 84.8 เป็นเพศชาย ร้อยละ 15.2 และร้อยละ 9.1 ตามลำดับ นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 97.0 และร้อยละ 90.9 ตามลำดับ กลุ่มควบคุมมีอายุเฉลี่ย 53 .60 ปี (SD = 7.29) กลุ่มทดลองมีอายุเฉลี่ย 47.18 ปี (SD = 10.52) สถานภาพสมรส คู่ ร้อยละ 78.8 และร้อยละ 75.8 ตามลำดับ กลุ่มทดลอง สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 39.4 ประถมศึกษา ร้อยละ 27.3 และมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 24.2 ตามลำดับ กลุ่มควบคุมสำเร็จชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 60.6 มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 18.2 และมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 15.2 ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 84.8 และร้อยละ 69.7 ตามลำดับ ระยะเวลาปฏิบัติงานในกลุ่มทดลองเฉลี่ย 10.48 ปี (SD = 6.98) ส่วนกลุ่มควบคุม มีระยะเวลาปฏิบัติงานเฉลี่ย 16.30 ปี (SD = 10.70)

2. **ผลการเปรียบเทียบความรู้ การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนและหลังการทดลอง** พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความรู้ การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง สูงกว่ากลุ่มควบคุม ($t = 7.884, 4.347, 10.208$ ตามลำดับ) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .001 ส่วนก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยความรู้ การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ไม่แตกต่างกัน ($t = 0.804, 0.547, \text{และ } -0.478$ ตามลำดับ $p > .05$) (ตาราง 1)